EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	87825
SERVICIO	:	MEDICINA HSC			
FECHA	:	03-07-2024			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: GONZALO PATRICIO BRAVO FERRADA			RUN	: 11.809.307-0
F.Nac	: 19-07-1971	Edad	: 52 AÑOS, 11 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: NINQUIHUE STA ROSA ACT			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-06-12	Fecha Egreso	: 03-07-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Sepsis abdominal Resuelta
--> obs PBE como punto de partida
2. Cirrosis hepatica Alcoholica descompensada
--> MELD Na: 19 pts | CHILD C | ACLF/CLIFF: 37 ptos
--> HTP Clinicamente significativa + Varices ligadas
--> Encefalopatia G0
--> Hepatectomia VI + Gastrectomia total + Esplenectomia (2021)
--> Hipoalbuminemia severa
3. Anemia de enfermedades cronicas
4. Diskalemias resueltas
5. LPP Sacra G2
6. HTA
7. Desnutricion mixta severa
8. Dependencia moderada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K70.3-CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I85.9-VARICES ESOFAGICAS SIN HEMORRAGIA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. G93.4-ENCEFALOPATIA NO ESPCIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. D63-ANEMIA EN ENFERMEDADES CRONICAS CLASIFICADAS EN OTRA PRATE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. E43-DESNUTRICION PROTEICOCALORICA SEVERA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. D68-OTROS DEFECTOS DE LA COAGULACION (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
7. S31.0-HERIDA DE LA REGION LUMBOSACRA Y DE LA PELVIS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Masculino De 52 Años, Con Antecedentes Mórbidos De Hta, Dm Sin Tto, Dhc Oh, Gastrectomía Por Varices Esofago-Gastricas No Ligables En Oct 2022 Con Resección Hepática Parcial Y Esplenectomía, Sin Alergias Conocidas. consulta por Fiebre, Inapetencia, Emesis, Ictericia, Enflaquecido, con Compromiso Del Estado General De 3 Dias De Evolución. se realiza Tc De Tórax que Impresióna Importante Derrame Pleural Izquierdo Asociado A Consolidaciones Atelectásicas De Ambos Lóbulos, Principalmente El Lóbulo Inferior izquierdo Y Moderado Derrame Pleural Derecho Asociado Consolidación Atelectásica Parcial Del Lóbulo Inferior Ipsilateral. Ateromatosis Coronaria Y Aórtica.Signo De Daño Hepático Crónico Con Hipertensión Portal. Se Realiza Toracocentesis Diagnostica con criterios de light negativos, y cultivo negativo, correspondiente a trasudado, probablemente en contexto de pleuroascitis, se realiza terapia depletiva con diureticos mas ATB en contexto de alto riesgo de PBE, completando 14 dias, sin elevacion de parametros inflamatorios, y de buena respuesta. durante hospitalizacion con evolucion fluctuante de encefalopatia, que cede logrando depocisiones. discoagulopatia secundaria a DHC + Anemia por Varice sangrante, que requieió transfusion de GR y plaquetas, actualmente desde el punto de vista hemodinamico, paciente de buena evolucion, cercano a su condicion basal, Sin requerimientos de O2 suplementario con disminucion de pleuroascitis, permanece orientado con dolor abdominal leve y distencion, ultimos paraclinicos evidencian deterioro funcional severo hepatico, con hidroelectroliticos que destacan hipokalemia leve, el dia de hoy normalizados, Funcion renal estable, manteniendo depocisiones. dado resolucion de conflictos agudos, se decide alta medica con HODOM para seguimiento, curacion de LPP y KTM de rehabilitacion por 5 dias.

PLAN DE MANEJO:

- Continuar suplementacion de potasio VO por 5 dias
- Seguimiento por HODOM + KTM + Curacion de LPP sacra
- ATB profilaxis por inmunosupresion secundaria a Cirrosis OH + Esplenectomia, Verificar calendario de vacunas y administrar
- Ajusto manejo en contexto de cirrosis hepatica

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen liviano hiposodico, hiperproteico
3. Hidratacion oral, maximo 1000cc al dia
4. No OH, no AINES, no Cremas cosmeticas

5. Rifaximina 200 c/8 horas vo x 14 dias
6. Acido ursodesoxicolico 250 mg c/12 horas x 30 dias
7. Lactulosa 40cc c/8 horas vo
8. PEG 1 sobre diluido en 250cc de agua c/ 12 horas vo, suspender cuando hayan mas de 2 depocisiones diarias
9. ferranim 1 capsula c/12 horas vo
10. Acido folico 1 comprimido c/dia vo
11. Furosemida 40mg c/dia vo
12. Espironolactona 25mg c/8 horas vo
13. Carvedilol 6.25mg 1/2 comprimido vo
14. Ciprofloxacino 500mg 1 c/12 horas x 14 dias
15. Metamizol 300mg 1 c/8 horas SOS dolor
16. Slow K 600mg 2 comp c/8 horas vo x 5 dias
17. Continuar KTM 1 vez al dia en HODOM
18. Continuar Curaciones de LPP en HODOM
19. Vigilar Condicion clinica de paciente en visita
20. Eventualidades informar a Medicina
21. Reconsultar SOS signos de alarma
22. Retomar controles en Consultorio de origen
23. Control en Medicina en 30 dias

EXÁMENES Y RESULTADOS

26/06 Alb: 2,9 * | Crea: 0,50 * | Ca: 8,6 | Fosf Alk: 90 | Bil Ind: 6,18 * | Bil Dir: 7,12 * | Bil Tot: 13,30 * | GOT: 69 * | GPT: 36 | GGT: 58 | Fósf: 1,9 * | LDH: 177 | MDRD: 174,61 | Lact: 1,8 | PCR: 40,8 * | Uremia: 19 | Na: 137,00 | K: 3,60 | Cl: 105,00 | Hb: 7,1 * | HTO: 21,0 * | GB: 11,60 * | Plaq: 124 * | Seg: 62 | Linf: 15 | Mono: 20 * | Eos: 2 | Baso: 1 | INR: 2,62 * | TP %: 29 * | TP seg: 32,7 | Procalcitonina: 0,39 | pH: 7,55 * | pCO2: 26,2 * | pO2: 76,4 * | HCO3 ACT: 23,3 | BE (B): 1,8 | O2 SAT: 96,0 | A-aDO2: 41,2 *

Control en: 14 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO